

Mózg się chronił — *to nie jest „opór”*

Dysocjacja w C-PTSD to kontinuum: od chwilowego „zoning out” po fragmentację. Terapeuta interpretujący to jako „brak motywacji” zatrzymuje terapię.

CZAS: 10–20 min nauki rozpoznawania + grounding **REALIZACJA:** Faza 1 stabilizacji, ciągła

ŹRÓDŁO: Lanius i in. (2010, 2017, *dissociative subtype*); Liotti (2004, 2011, dezorganizowane przywiązanie); Van der Hart i in. (2006, dysocjacja strukturalna); Brand i in. (2012, metaanaliza); Carlson & Putnam (1993, DES-II)

JAK UŻYWAĆ

W sekcji 01 — **spektrum form dysocjacji**: depersonalizacja, derealizacja, amnezja, dysocjacja emocjonalna i somatyczna. W sekcji 02 — **neurobiologia podtypu dysocjacyjnego** (Lanius): odwrotny wzorzec mózgu niż w PTSD hiperaktywnym. Sekcja 03 — **twoja mapa dysocjacji**: formy, wyzwacze, znaki ostrzegawcze. Sekcja 04 — protokół grounding i plan z terapeutą.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Dysocjacja w C-PTSD jest **kontinuum** — od chwilowego „zoning out” po pełną fragmentację (DID — zaburzenie tożsamości dysocjacyjnej). **Formy**: (1) *depersonalizacja* — „patrzę na siebie z zewnątrz”, „to nie jest moje ciało”; (2) *derealizacja* — „jak we śnie”, „nic nie wydaje się realne”; (3) *amnezja* — luki w pamięci, „nie pamiętam godzin lub dni”; (4) *emocjonalna* — odrętwienie, „nic nie czuję”; (5) *somatyczna* — „nie czuję ciała”, analgezja; (6) *strukturalna* (Van der Hart i in., 2006) — „części” osobowości: *Apparently Normal Part* kontra *Emotional Part*. Liotti (2004, 2011): dysocjacja jest *kontynuacją* dezorganizowanego przywiązania — korelacja $r = 0,35$. Lanius i in. (2010, 2017, fMRI): **podtyp dysocjacyjny PTSD** (rozpoznany w DSM-5) ma *odwrotny wzorzec mózgu* niż hiperaktywny PTSD — *hiperaktywacja* przyśrodkowej kory przedczołowej (mPFC) i *dezaktywacja* ciała migdałowatego. To sugeruje, że dysocjacja jest *strategią chroniącą* — mózg „wyłącza” reakcję alarmową przez nadmierną kontrolę odgórną (ang. *top-down*), kosztem kontaktu z teraźniejszością i emocjami. Brand i in. (2012, metaanaliza): fazowe leczenie z naciskiem na *grounding* jest rekomendowane dla podtypu dysocjacyjnego. **Kluczowe w sesji**: jeśli pacjent dysocjuje — *przerwij* pracę z traumą *natychmiast*, *grounding* (5-4-3-2-1, kontakt wzrokowy, głos terapeuty, dotyk jeśli bezpieczny), stabilizacja. **Nie** idź dalej. Terapeuta, który nie rozpoznaje dysocjacji, interpretuje ją jako „opór” lub „brak motywacji”. Klient po sesji nie pamięta jej. Bez rozpoznania dysocjacji terapia stoi w martwym punkcie. DES-II (*Dissociative Experiences Scale*, Carlson & Putnam, 1993) — narzędzie kliniczne do oceny nasilenia dysocjacji co kilka miesięcy. Modalności terapeutyczne (np. EMDR) wymagają *modyfikacji* dla pacjentów dysocjacyjnych — tytulacja, krótkie zestawy, częste kotwiczenie.

01



Spektrum form dysocjacji

DEPERSONALIZACJA

„Patrzę na siebie z zewnątrz”, „to nie jest moje ciało”. Odłączenie od własnej osoby, „jakbym była/był obok”.

DEREALIZACJA

„Jak we śnie”, „nic nie wydaje się realne”. Świat za szybą. Mgła, nierealność otoczenia.

AMNEZJA

Luki w pamięci. „Nie pamiętam, jak wróciłem/-am do domu”, „nie pamiętam godzin/dni”. Nieciągłość świadomości.

EMOCJONALNA

Odrętwienie, „nic nie czuję”. Płaskość afektywna jako forma ochrony. Często mylona z depresją.

SOMATYCZNA

„Nie czuję ciała”, analgezja, niezauważanie zranień. Odciecie od sygnałów wewnętrznych.

STRUKTURALNA

„Części” osobowości (Van der Hart). W skrajnej formie DID. Pomiędzy stanami brak ciągłości doświadczenia.

02 ? Neurobiologia — podtyp dysocjacyjny (Lanius, fMRI)

Lanius i in. (2010, 2017, fMRI) pokazali, że w **podtypie dysocjacyjnym PTSD** (DSM-5) mózg ma **odwrotny wzorzec** niż w klasycznym hiperaktywnym PTSD: **hiperaktywacja przyśrodkowej kory przedczołowej** (mPFC) i **dezaktywacja ciała migdałowatego**. Innymi słowy — mózg „wyłącza” reakcję alarmową przez nadmierną kontrolę odgórną (ang. *top-down*), kosztem kontaktu z teraźniejszością i emocjami. To *strategia chroniąca*, nie wada. Implikacja kliniczna: ten podtyp wymaga *innego* podejścia terapeutycznego niż hiperaktywny PTSD — Brand i in. (2012, metaanaliza) rekomendują **fazowe leczenie** z naciskiem na *grounding* i stopniowe przywracanie kontaktu z emocjami i ciałem.

03 ✎ Moja mapa dysocjacji + plan grounding

MOJA DOMINUJĄCA FORMA DYSOCJACJI

— depersonalizacja / derealizacja / amnezja / emocjonalna / somatyczna; co najczęściej, jak długo

MOJE WYZWALACZE

— sytuacje, osoby, miejsca, dźwięki, godziny dnia; im więcej rozpoznam, tym wcześniej mogę zadziałać

WCZESNE ZNAKI OSTRZEGAWCZE

— co odczuwam 30–60 sek przed pełną dysocjacją (mgła, mrowienie, dzwonienie w uszach, „znikanie”)

MÓJ PROTOKÓŁ GROUNDING W DYSOCJACJI

— 5–4–3–2–1, kontakt fizyczny, zimna woda, ruch — co działa najszybciej; gdzie noszę przypomnienie

Klucz: dysocjacja w C-PTSD *nie* jest „oporem”, „brakiem motywacji”, „lenistwem”. To **strategia chroniąca** — mózg wyłącza reakcję, gdy nie ma innej drogi przetrwania. Lanius i in. (2010): to nawet *odrębny* podtyp neurobiologiczny, nie wariacja klasycznego PTSD. Terapeuta, który nie rozpoznaje dysocjacji, interpretuje ją jako „*klient nie chce pracować*” i pcha dalej — co *pogłębia* dysocjację. Skuteczne jest natomiast: *natychmiastowe przerwanie* pracy z trudnym materiałem, *grounding*, *walidacja* („to była dysocjacja, nie twoja wina, mózg się chronił”), *poszerzanie okna tolerancji* w Fazie 1, dłuższa Faza 1 niż w klasycznym PTSD. Modalności typu EMDR czy ekspozycja *wymagają modyfikacji* w podtypie dysocjacyjnym — tytulacja, krótkie zestawy, częste kotwiczenie zasobów.

△ Jeśli rozpoznajesz fragmentację strukturalną — wrażenie „części” sobie, luki w pamięci codziennej, „obudzenie” w nieznanym miejscu — szukaj klinicysty specjalizującego się w dysocjacji strukturalnej (Van der Hart, ISSTD guidelines). To wymaga specyficznego treningu i dłuższej terapii (3–7 lat lub więcej). Niewłaściwie prowadzona terapia może destabilizować. DES-II jest dostępne online jako narzędzie skryningowe — warto wypełnić z klinicystą.